

Informe de evaluación Terapia Ocupacional

1. Antecedentes personales

Nombre	Boris Macuada Vergara	Cuidador principal	Javiera Vergara - Claudio Macuada
Sexo	Masculino	Fecha de nacimiento	2 de junio del 2021
Edad	1 año 4 meses	Fecha de Evaluación	19 de octubre 2022
Diagnóstico	S/D	Fecha de entrega	20 de diciembre 2022
RUT	27.547.447-9	Terapeuta Ocupacional	Claudia Yáñez González

2. Antecedentes generales

Boris, menor de 1 año 4 meses, ingresa a Terapia Ocupacional por evaluación diagnóstica, presentando desarrollo psicomotor típico para su edad, sin embargo durante la entrevista con los padres, refieren presentar problemáticas a nivel sensorial propioceptiva y táctil en diferentes niveles de dificultad.

El menor vive con ambos padres, en la comuna de Las Condes, durante la entrevista se menciona que el menor peso 2,680 kg y midió 49 cm, a las 38 semanas de gestación por cesárea. Embarazo de alto riesgo debido a los antecedentes médicos de la madre (dg. Lupus). La madre de Boris, refiere que el embarazo fue por fertilización In Vitro.

Una de las principales problemáticas que observan los padres, es durante la actividad de sueño, alteración sensitiva táctil (menor intensidad), alteración de sensibilidad propioceptiva y dificultades con la tolerancia a la frustración. Los cuales, estos son el motivo de consulta a Terapia Ocupacional.

3. Instrumentos de evaluación

- Anamnesis
- Observación clínica
- Entrevista semiestructurada con los padres
- Evaluación y descripción de áreas del desempeño ocupacional en base al Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso. De la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), 3° edición, año 2014.
- Escala de juego de Susan Knox

4. Observación Inicial

La evaluación de Terapia Ocupacional se realiza en el Jardín Infantil Caiquen, el cual el menor asiste, dentro de este jardín cuenta con una sala sensorial, es aquí donde se realiza la entrevista evaluación y sesión. El menor ingresa a la Sala Sensorial, junto a su padre Claudio y madre Javiera, Boris ingresa presentando estado de ánimo eutímico, pero mediante el proceso de la evaluación este se iba elevando debido a la cantidad de estímulos de la sala, realiza contacto visual con sus padres y terapeuta, conectado además con el entorno tanto físico y social, se encontraba vigil y con un estado de alerta alto. Durante la evaluación se puede observar que Boris realiza juego libre predominantemente funcional, explorando los objetos que existen en la sala, donde invita constantemente a jugar con él. Boris, muestra todos los objetos de la sala presentando intención comunicativa hacia ellos.

Se observa que el menor realiza marcha independiente sin asistencia ni apoyo, la cual es correspondiente a su edad, en la evaluación, se observa que logra reconocer parte de su cuerpo (pelo, boca, cabeza) sin embargo se necesita reforzar esta área en los objetivos por lograr.

En relación a la evaluación inicial, se puede mencionar que el menor realiza contacto visual en todo momento, reconociendo los juegos dispuestos en toda la sala, los padres y/o terapeuta ocupacional es un colaborador en su juego para facilitar los materiales que él necesita, conectando en ciertas ocasiones para un juego cooperativo, sin embargo esta área es correspondiente a la edad cronológica de Boris.

Durante las evaluaciones, no se observan conductas repetitivas, ni estereotipias, sin embargo, tomando en cuenta la edad cronológica del menor y lo mencionado por los padres en la entrevista el menor presenta conductas orofaciales llevándose los objetos a la boca, sin embargo según lo referido por los padres el menor mastica el objeto y luego lo devuelve por lo que esto es de gran preocupación para ellos y el contexto escolar.

Área conductual y socioemocional

En esta área se puede mencionar que el menor, no presenta mayores dificultades, desde la observación y evaluación escolar, logra compartir con otros compañeros, explora el lugar donde se encuentra, sin embargo, los padres refieren que el menor presenta una baja tolerancia a la frustración expresado con llantos y golpeándose la cabeza en una superficie resistente, esta acción se especificará de mayor forma en el ítems de “*Perfil Sensorial*”.

Con lo evaluado durante la entrevista y evaluación se puede mencionar que en relación a la edad cronológica del menor no se observan dificultades ni problemáticas.

Perfil Sensorial

En esta área se puede mencionar que, el menor durante las evaluaciones y la entrevista inicial con los padres, se puede mencionar que puede existir mayor dificultad en la **Estimulación Vestibular**, debido a que en ciertos episodios durante el día, las tías del jardín mencionan que presenta dificultad cuando tienen que mudarlo, ya que el menor no tolera la posición decúbito supino para ejecutar la acción, sin embargo, esto se debe ir observando sesión a sesión debido a que el menor logra mantenerse por un tiempo sobre balón terapéutico con movimiento (rebote) sin dificultad, logra subirse sobre figuras de espuma, y no se observan dificultades para estar en brazos de otra persona. Cabe mencionar que a momento de la entrevista de Terapia Ocupacional, el menor hacía recientemente su ingreso al jardín por lo que puede estar aún en proceso de adaptación escolar (1 mes aproximadamente) por lo que esta área aún se encuentra en observación.

Desde la **Estimulación Táctil**, se puede mencionar que el menor aún se encuentra en fase oral, los padres mencionan que “*todo lo que encuentra se lo lleva a la boca*”, presentando preocupación en esta área, sin embargo, estos objetos que se lleva a la boca tienen una característica, son suaves, que sea masticable, de tamaño pequeño, lo introduce a su boca y luego lo saca para entregárselo a su cuidador. Sin embargo, es una gran preocupación para los padres y el equipo del Jardín Infantil ya que el menor puede presentar algún accidente y se pretende evitar esta conducta con objetos que sean pequeños. Desde esta área se menciona también que el menor presenta dificultad cuando le tienen que cortar y lavarse el pelo, manifestando esta frustración con llantos y gritos.

Desde la **Estimulación Propioceptiva** se puede mencionar que el menor no presenta dificultades, logra reconocer su cuerpo en el espacio, logra reconocer su cuerpo y las partes del frente a un espejo, correspondiente a su edad cronológica de Boris. Sin embargo, se pretende seguir evaluando esta área.

Habilidades motoras y praxis

Respecto a esta área, se puede referir que el menor ingresa a la sala de estimulación realizando marcha independiente, sin apoyo ni asistencia, logra gateo funcional para trasladarse sin necesidad de realizar marcha. A modo general, el menor se encuentra dentro de los parámetros típicos psicomotores correspondiente a su edad cronológica.

En relación a las habilidades motoras gruesas, se puede mencionar que el menor logra marcha independiente, logra trepar diferentes niveles como los sillones, sillas, cama, etc. Además logra subir escaleras realizando este movimiento (pie-pie-mano-mano) alternando cada una, de manera independiente con la supervisión de un adulto. Además, cabe mencionar que el menor logra golpear balones, dar pequeños brincos presentando caídas de vez en cuando. Dentro de esta área, es importante referir que el equilibrio se encuentra de manera típica, con ciertas dificultades y tendencia a caer pero normal para su etapa psicomotriz, presenta tono y postura muscular típico sin embargo se recomienda seguir evaluando y reforzando sesión a sesión.

Con respecto, a las habilidades motoras finas, se puede mencionar que el menor logra tomar objetos con prensión palmar, manipulando de manera efectiva, logra realizar prensión digital con tres dedos (pulgar, índice y medio) para tomar objetos pequeños realizando encajes. No se observan dificultades o alteraciones en relación a la edad cronológica.

Actividades de la vida diaria básica

- **Alimentación:** Mediante la entrevista con los padres, desde esta área no se observan dificultades, el menor logra tomar cuchara realizando prensión palmar completa, paulatinamente logra ir mejorando la ejecución de la actividad, sin embargo es dependiente en esta área debido a su edad. No se observan alteraciones, mediante la entrevista se refiere que actualmente su comida tiene consistencia cremosa o semisólida (de momento no se diagnostica alergia alimentaria).
- **Vestimenta:** Boris dependiente en esta área por edad cronológica sin embargo la madre refiere como colaborativo, sin embargo para el cambio de pañal refieren que el menor al posicionarse en decúbito supino presenta gran frustración para la ejecución de la actividad mencionada con anterioridad, por lo que los padres refieren preocupación en esta área.
- **Higiene:** Desde esta área, se puede mencionar que el menor presenta total asistencia, de momento aún ocupa pañales, lo que es típico para la edad del menor donde no se presentan dificultades, sin embargo, los padres refieren que Boris presenta dificultad para registrar el estímulo del lavado de pelo, manifestando alteración en la conducta, el menor se debe lavar tapado con una manta para evitar episodios de llanto o frustración, esta conducta ocurre en el hogar y en el contexto escolar.

- **Descanso y sueño:** En esta área, los padres refieren que Boris presenta dificultad en la conciliación del sueño, duerme siesta de manera regular, sin embargo esta debe ser a cierta hora ya que si duerme hasta más tarde durante la tarde, los padres mencionan que el menor presenta mayor dificultad para poder dormir en la noche. Por lo que se requiere seguir trabajando y realizando adaptaciones en el hogar para regularizar esta área.

Educación

Debido a la crisis sanitaria que se estaba presentando en el año 2020, en el año 2021 el menor no ingresa a establecimiento educacional debido a las restricciones que existían en ese año, sin embargo, ingresa al Jardín Infantil Caiquen en el mes de septiembre del año 2022, en el cual de momento aún se encuentra en un periodo adaptativo, asistiendo media jornada, en este jardín infantil es donde se encuentra con Terapia Ocupacional una vez a la semana en la sala de estimulación sensorial.

Participación social

En relación a esta área se puede mencionar que el menor no presenta dificultad, no se observan conductas alteradas con sus pares, realiza contacto visual e intención comunicativa a los menores que se encuentra en el jardín. Sin embargo se necesita seguir evaluando esta área para descartar dificultades que se vayan presentando. Además, no se observan dificultades en la relación con sus padres, el menor

Juego

En relación al juego se evalúa con escala de juego de Susan Knox, se puede observar lo siguiente:

Edad cronológica del menor: **16 meses (a la evaluación terapéutica)**

MANEJO DEL ESPACIO (las áreas se encuentran acorde a la edad cronológica del menor 12 a 18 meses)

- **Motor grueso:** se mantiene de pie sin apoyo, se sienta, se dobla y recobra el equilibrio, camina con amplia base de sustentación, movimientos amplios que involucran grandes grupos musculares, lanza pelota.

Observación: El menor se encuentra dentro de las características de este aspecto, sin embargo, se necesita reforzar aún más el equilibrio y el lanzar la pelota.

- **Interés:** práctica patrones de movimiento básicos, experimenta con movimientos, explora distintas sensaciones kinestésicas y propioceptivas, objetos que se mueven (ej: pelotas, camiones, juguetes traccionables)

MANEJO DE MATERIAL (las áreas se encuentran acorde a la edad cronológica del menor 12 a 18 meses)

- **Manipulación:** arroja, inserta, tira, traslada, voltea, abre, cierra

Observación: En esta área el menor se encuentra más adelantado a la evaluación (18 a 24 meses ya que logra operar juegos mecánicos, separa cuentas, ensarta cuentas en una cuerda, sin embargo dentro de todas las otras características se encuentra dentro de la edad cronológica por que se clasifica en los 12 a 18 meses).

- **Construcción:** apila, separa, junta, pequeño intento de lograr un producto, relaciona dos objetos apropiadamente (ej: tapa en olla)
- **Propósito:** variedad de esquemas, importancia del proceso, ensayo y error, juego relacional
- **Atención:** cambia rápido

ACTUACIÓN (las áreas se encuentran acorde a la edad cronológica del menor 12 a 18 meses)

- **Imitación:** de acciones simples, eventos presentes y adultos, imita movimientos novedosos, asocia esquemas simples (ej: pone a la persona en el auto y lo empuja)

Observación: Se puede mencionar que el menor se encuentra dentro de esta área, sin embargo se necesita reforzar el área de imitación tanto en rostro como en cuerpo.

- **Dramatización:** comienza a actuar usándose a sí mismo (ej: se alimenta con la cuchara), actúa sobre objetos animados e inanimados.

PARTICIPACIÓN (las áreas se encuentran acorde a la edad cronológica del menor 12 a 18 meses)

- **Tipo:** Combinación de solitario y observador, comienza interacción con pares
- **Cooperación:** busca atención sobre sí, demanda juguetes, apunta, muestra, ofrece juguetes pero en cierta forma posesivo, persistente.
- **Humor:** ríe ante eventos incongruentes
- **Lenguaje:** parlotea a sí mismo durante el juego, usa gestos y palabras para comunicar deseos, nombra objetos, saluda a otros, responde a requerimientos simples, bromea, exclama, protesta, combina palabras y gestos.

En conclusión, se puede mencionar en relación a la pauta de evaluación, el menor se encuentra dentro de su edad cronológica, sin embargo hay aspectos de la pauta que se deben reforzar.

Diagnóstico de Terapia Ocupacional

Con todo lo mencionado dentro del informe de evaluación de Terapia Ocupacional relacionándolo a su edad cronológica, se puede referir que el menor necesita estimulación temprana a nivel del área motor grueso y fino para fortalecer aspectos que se encuentran con mayor dificultad como lo es el lanzamiento de balones con los pies, mayor equilibrio y mejorando la base de sustentación en posicionamiento bipedo. Con respecto al área de habilidades motoras finas se puede mencionar que el menor no presenta dificultad pero para estas actividades el momento de atención es bajo. Se requiere empezar a realizar circuitos motores básicos y poco a poco ir complejizando para poner reglas a los juegos para fortalecer el respeto de turnos y seguimiento de pasos.

En relación a la estimulación sensorial, se puede mencionar que se presentan dificultades en ciertas áreas de la estimulación vestibular como el cambio de posicionamiento de sedente a decúbito supino, de ciertas alturas, sin embargo el menor mediante las primeras sesiones de evaluaciones logra responder adecuadamente a las diferentes alturas, estar en brazo, sobre el balón terapéutico y sobre estructuras pequeñas, pero le disgusta el cambio de posicionamiento mencionado con anterioridad. También presenta dificultades en el baño, por lo que se encuentra estrechamente relacionado con el área sensorial, sin embargo se debe identificar qué es lo que disgusta de este aspecto (ruido, textura del agua, temperatura, la ducha, etc.)

Por último, es importante reforzar sesión a sesión la participación social tanto con los familiares como con sus pares, paulatinamente incorporándose en el juego del menor para ir de colaborador a cooperador en el juego para así ir reforzando los turnos y seguimiento de instrucciones. Comenzando con instrucciones simples como "Toma y Dame", reconocer partes del cuerpo y posicionarlas en un mapa corporal, trasvasiar, etc.

Informe de Intervención Especialidad de Terapia Ocupacional

No.	OBJETIVOS	Obj. NL	Obj. EP	Obj. L
1	Que Boris mejore habilidades motoras durante el juego			
1.1	Que Boris fortalezca equilibrio dinámico en el juego.			
1.2	Que Boris fortalezca musculatura en extremidad inferior para mejorar marcha estable			
1.3	Que Boris mejore gateo durante el juego con implementos terapéuticos.			
1.4	Que Boris incorpore mayores juegos que incluya prensión fina.			
1.5	Que Boris logre lanzar pelotas incorporando intención funcional en el juego.			
1.6	Que Boris logre trasvasar de un recipiente a otro durante el juego.			
1.6	Que Boris fortalezca prensión palmar con implementos terapéuticos			
1.7	Que Boris fortalezca pinza digital trípode durante el juego			
2	Que Boris desarrolle habilidades conductuales en el juego			
2.1	Que Boris logre seguimiento de instrucciones simples durante el juego			
2.2	Que Boris logre un circuito motor simple.			
2.3	Que Boris logre habilidad social básica: Toma y Dame durante el juego			
2.4	Que Boris incorpore respeto de 1 turnos durante el juego			
2.5	Que Boris logre reconocimiento de entorno social mediante el juego			
3	Que Baltazar mejore habilidades cognitivas durante el juego			
3.1	Que Boris aumente atención focalizada durante el juego			
3.2	Que Boris logre actividades de imitación durante el juego			
3.3	Que Boris mejore respuestas adaptativas ante estímulos frustrantes			
4	Que Boris logre respuestas adaptativas a estímulos sensoriales del ambiente			
4.1	Que Boris logre respuesta adaptativa en la actividad de higiene			
4.2	Que Boris logre incorporar actividades de cambios de posicionamiento durante el juego.			
4.3	Que Boris explore juegos sensorial táctil en actividades de alimentación			
4.4	Que Boris explore juegos sensorial táctil en actividades de la sala de estimulación.			
4.5	Que Boris logre respuestas adaptativas a ruidos del ambiente			

Tiempos: 1 sesión semanal de Terapia Ocupacional de 50 a 60 minutos por 6 meses para evolución.

Observaciones

- Generalizar tareas realizadas en Terapia Ocupacional y actividades funcionales del hogar.
- La familia debe responder de manera responsable a las indicaciones realizadas desde Terapia Ocupacional instaurando objetivos en el día a día o espacios de interacción con el menor y no interferir en el plan de intervención realizando lo contrario.
- Establecer espacios de interacción con el menor promoviendo independencia en actividades diarias y juego.

Sugerencias generales

- Fortalecer indicaciones simples y cotidianas para el menor realizando actividades de las cuales presentan mayor competencia para regular la frustración del menor.
- Promover juegos colaborativos para que el menor incorpore respeto de turnos.
- Promover independencia en el menor principalmente en actividades de vida diaria, como por ejemplo que el menor logre tomar los utensilios de manera independiente. Generar mayor exploración en alimentos.
- Favorecer exploración de espacios sociales, plazas, cumpleaños, espacios recreativos, etc. e identificar cuales gustan y cual disgusta.
- Incorporar rutina saludable en el contexto hogar, seguir indicaciones del cuidador principal y estrategias entregadas desde sesiones de Terapia Ocupacional.
- Establecer horarios para actividades de las cuales se pueda flexibilizar.
- Presentar fotos o imágenes y nombrar los familiares o círculo más cercano para fortalecer intención comunicativa

Se extiende el presente informe para los fines que el interesado estime conveniente

Claudia Yáñez González

Terapeuta Ocupacional
Lic. en Terapia Ocupacional
19.038.351-2
N° de Registro: 622790